

# 야간 하지 경련, 진성 경련인지부터 가릅니다

근육 경련·야간 하지 경련 — 1차 진료 임상 지침 (의료진 검수용)

## 진성 경련인가 — 첫 갈림길은 병력 청취

50세 이상 성인의 33%(60세 이상에서는 약 50%)가 겪습니다 — “쥐가 난다” 안에 다른 질환이 섞여 있습니다

### 진성 경련(true cramp)이란

근육이 갑자기 제멋대로 수축해 몹시 아프고, **손으로 만져질 만큼 단단히** 뭉칩니다. 수 초~수 분(드물게 10분) 이어지고, 풀린 뒤 압통이 48~72시간 남기도 합니다.

### 병력에서 묻는 세 가지

정말 뭉치는가 · 스트레칭으로 바로 풀리는가 · 쉴 때인가 움직일 때인가.

| 헛갈리는 것           | 구별점                                       |
|------------------|-------------------------------------------|
| 근구축(contracture) | 겉보기엔 쥐 같지만 근전도가 조용함(전기적 침묵) · 스트레칭으로 안 풀림 |
| 근간대경련            | 0.2초 이내로 짧게 핵 움직임 · 통증 없음                 |
| 근긴장이상            | 반대 방향 근육이 함께 수축해 자세가 비틀림                  |
| 테타니              | 양쪽 대칭 · Chvostek-Trousseau 징후 양성          |
| 하지불안증후군          | 움직이고 싶은 충동만 · 실제로 뭉치지 않음(국내 유병률 5.4~7.5%) |

Tip · 활동 중에만 생기는 종아리 통증은 경련이 아니라 말초동맥질환·척추관협착증을 먼저 의심합니다.

근거 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

# 근육의 병이 아니라 신경의 과흥분입니다

치료 선택이 바뀌는 지점 — 전해질 교정만으로 설명되지 않습니다

## ⚡ 말초 운동신경 과흥분

경련 신호는 근육이 아니라 **운동신경 끝**에서 시작합니다(근전도 소견).

## 📖 근방추·골지건기관 불균형

근육이 짧아진 채 피로가 쌓이면 흥분은 늘고 억제는 줄어듭니다. 스트레칭이 바로 듣는 이유입니다.

## 💡 TRP 채널 매개 가설

TRP 채널이 자극되면 척수 억제 경로로 과흥분이 곧바로 가라앉는다는 가설입니다 [PMID 28192854](#).



Tip · 혈청 마그네슘이 정상이라고 조직까지 정상은 아니지만, 그것이 보충 효과를 보장하지도 않습니다.

근거 · PMID 28192854 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

## ▶ 이 경련은 그냥 경련이 아닙니다

하나라도 있으면 원인 검사를 먼저 합니다 — 감별은 혈관·신경·대사·약물 네 축으로



### ▲ 이럴 땐 원인 검사부터

한쪽·같은 자리 반복 · 팔·몸통까지 · **근력저하·근위축·섬유속연축**(운동신경질환) · 걸을 때 유발 (말초동맥질환·협착증) · 약 시작 직후.

### 🌐 약이 원인일 때

이뇨제 · 베타작용제 · 스타틴 · 니페디핀 · 호르몬제 — 어느 쪽이 먼저인지가 핵심입니다.

### 🚩 바탕에 다른 병이 있다는 신호

간경변 · 만성콩팥병·투석 · 갑상선 · 당뇨 신경병증 · 임신 · 전해질 이상.

Tip · 특발성 야간 하지경련은 네 축을 모두 훑은 뒤에 붙이는 이름입니다.

근거 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

## 먹고 있는 약부터 확인합니다

다른 병·약 때문에 생긴 원인 중 가장 흔하고, 가장 잘 놓치고, 바로잡을 수 있습니다



### 확인하는 순서

① 최근 3개월 안에 시작·증량한 약 ② 경련 시작과 어느 쪽이 먼저인지 ③ 뺄 수 있는지, 바꿀 수 있는지.



### 약을 더하기 전에

경련만 보고 약을 더하기 전에, 이미 먹고 있는 약을 **뺄 수 있는지** 먼저 봅니다.

| 약                              | 어떻게 경련을 부르나 | 확인할 것                  |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 이노제                            | 칼륨·마그네슘 저하  | 전해질 · 시작 시점과 증상 시점     |
| 흡입 $\beta$ 작용제                 | 전해질을 흔들     | 시작·증량 시점과 비교           |
| 위산억제제(PPI) 장기                  | 마그네슘 저하     | 마그네슘 · 계속 필요한지         |
| 스타틴                            | 근육에 직접      | 근육효소(CK) 확인 후 감량·변경 검토 |
| 니페디핀 · 칼록시펜·<br>에스트로겐 · 정맥 철분제 | 보고된 약       | 시작 시점과 비교 · 바꿀 수 있는지   |

Tip · 다른 병·약 때문에 생긴 원인 중 가장 흔하고 바로잡을 수 있는 원인입니다.

근거 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

## 검사는 이차 원인이 의심될 때 고릅니다

전형적인 야간 하지경련은 병력과 진찰로 평가합니다 — 단서가 있을 때 해당 검사를 선택

### 1. 기본

#### 이차 원인이 의심되면

병력·진찰에서 단서가 있을 때 고릅니다 — 나트륨·칼륨·칼슘(알부민 보정)·마그네슘·혈당/당화혈색소·콩팥·간기능·갑상선(TSH)·근육통이 있으면 근육효소(CK).



### 2. 상황별

#### 의심될 때 추가

술·영양결핍 → 인(P)·하지불안증후군 감별 → 페리틴·신경병증 의심 → 비타민 B12.



### 3. 의뢰

#### 큰 병원으로

근력저하·근위축·섬유속연축 → 근전도·신경전도검사·걸을 때 유발+맥박 약함 → 발목-팔 혈압비(ABI)·다리로 뻗치는 통증 → 요추 MRI.



#### 판정 — 특발성으로 봅니다

병력·진찰에서 이차 원인 단서가 없고(고른 검사는 정상) 먹는 약·신경 진찰에 이상이 없으면 **특발성 야간 하지경련**으로 봅니다.

Tip · 검사를 넓게 벌이기보다, 병력에서 나온 단서에 맞는 항목만 고릅니다.

근거 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

# 1차 치료는 약이 아니라 스트레칭입니다

근거가 가장 확실하고, 부작용이 없고, 돈이 들지 않습니다

## 자기 전 종아리·허벅지 뒤 스트레칭

고령자 무작위 시험에서 자기 전 스트레칭이 경련의 횟수와 강도를 모두 줄였습니다 [PMID 22341378](#).

## 실제로 하는 방법

벽을 짚고 종아리를 편 채 **10초씩 3회**, 자기 직전 매일. 발끝을 몸 쪽으로 당긴 자세가 핵심입니다.

## 다시 평가하는 때

스트레칭을 시작하고 **6주 뒤** 처음 다시 봅니다. 잠자는 자세·수분·카페인·술도 함께 정리합니다.



Tip · '해볼 만한 것'이 아니라 1차 처방입니다 — 진료실에서 한 번 같이 해 봅니다.

근거 · PMID 22341378

## 밤새 발끝이 아래로 향하면 경련이 옵니다

약보다 먼저 바꿀 수 있고, 스스로 확인할 수 있습니다



### ⚠ 무엇이 문제인가

이불 무게로 발끝이 **밤새 아래로** 향하면 종아리가 짧아진 채 피로가 쌓입니다.

### 📖 바꿀 것

발치 쪽 이불을 느슨하게 해 발등이 눌리지 않게 합니다. 필요하면 베개로 발목을 **바로 세워** 받칩니다.

### 🧑 같이 바꿀 것

수분 · 카페인·술 줄이기 · 활동량 유지(너무 적어도, 갑자기 늘려도 경련이 옵니다).

Tip · 이불 무게는 좀처럼 확인하지 않는 항목입니다 — 한 번 살펴보면 오늘 밤부터 바꿀 수 있습니다.

근거 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

## 마그네슘은 음성, 퀴닌은 쓰지 않습니다

이 자료에는 용량표를 실지 않습니다 — 용량은 최신 허가사항·1차 자료로 확인

### 마그네슘 — 근거는 음성

특발성 야간 하지경련에서 가짜약과 차이를 입증하지 못했습니다  
[PMID 32956536](#) · 산화Mg RCT [PMID 28241153](#). 임신 ·  
 확인된 저마그네슘혈증 · 이뇨제·PPI 장기 복용일 때만  
 고려합니다.

### 퀴닌 — 쓰지 않습니다

효과는 있으나 혈소판감소증·QT 연장 위험으로 여러 나라가  
 제한했습니다 [PMID 25842375](#).

| 약        | 근거                                                     | 판단           |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 딜티아젬     | 규모가 작은 무작위 시험의 긍정적 신호<br><a href="#">PMID 11322688</a> | 권고하기엔 이릅니다   |
| 비타민 B 복합 | 소규모 무작위 시험 <a href="#">PMID 11301568</a>               | 보조적으로만       |
| 타우린      | 간경변 환자 경련 무작위 대조시험<br><a href="#">PMID 30136291</a>    | 간경변일 때(다음 장) |

Tip · “안 듣는다”가 아니라 “가짜약과 차이를 입증하지 못했다”가 정확한 표현입니다.

근거 · PMID 32956536 · 28241153 · 25842375 · 11322688 · 11301568

# 쥐가 난 순간 — 무엇을 하고, 무엇을 알아 둘까

바로 풀리는 원리는 스트레칭과 반사 억제입니다



01

## 손으로 늘려 펴기

쥐가 난 근육을 손으로 강하게 늘려 펴니다.  
풀리면 **마사지·온찜질**을 합니다.

가장 먼저 할 일



02

## 피클 주스 반사 억제

전기 자극으로 유발한 경련 실험에서 **피클 주스**를  
소량 마시자 흡수되기 전에 경련이 잦아졌습니다  
— 입안 자극 반사로 봅니다 [PMID 19997012](#).

야간 경련 효과는 미확인



03

## 풀린 뒤에 알아 둘 것

풀린 뒤에도 2~3일은 누르면 아플 수 있습니다.  
**2주 동안 증상 일지**를 적어 오게 합니다.

2주 일지 → 다시 진료

Tip · 밤에는 잠결에 대응하게 됩니다 — 말로만 듣지 말고 진료실에서 한 번 직접 해 봅니다.

근거 · PMID 19997012 · 원문 임상 지침 요약 · 개별 문헌 앵커 없음

## 특수 상황 — 앞의 결론을 그대로 쓰지 않습니다

간경변 · 혈액투석 · 임신, 세 경우는 따로 봅니다

### 간경변

#### 삶의 질을 가장 크게 떨어뜨립니다

먹는 타우린 [PMID 30136291](#) · 국내 4주 연구 [PMID 33381931](#). 흔한데도 진료 때 잘 말하지 않는 증상입니다.

### 혈액투석

#### 투석 처방 조정이 원인에 더 가깝습니다

비타민 E [PMID 19829096](#) · 가바펜틴 [PMID 26586051](#). 먼저 투석 처방을 살핍니다.

### 임신

#### 중기 이후 흔합니다

종아리 스트레칭 등 약을 쓰지 않는 방법이 1차입니다. **퀴닌은 임신 중 쓰지 않습니다.**

Tip · 간경변이 있으면 경련을 먼저 물어봅니다 — 환자가 먼저 말하지 않는 경우가 많습니다.

근거 · PMID 30136291 · 33381931 · 19829096 · 26586051

## 진료실에서 밟는 순서

대부분의 특발성 야간 하지경련은 설명과 스트레칭에서 끝납니다

### ① 감별

#### 진성 경련인가

단단하게 뭉침 · 늘리면 바로 풀림 ·  
수 초~수 분 — 헛갈리는 다섯  
가지를 먼저 거릅니다.

### ② 위험신호

#### 네 축 훑기

혈관 · 신경 · 대사 · 약물. 먹는  
약부터 보고, 단서가 있으면  
해당 검사.

### ③ 1차 처방

#### 자기 전 스트레칭

10초씩 3회 매일, 6주 뒤 다시  
평가 PMID 22341378.

### ④ 약물

#### 좁고 신중하게

퀴닌은 쓰지 않고, 마그네슘은  
부족이 의심될 때만  
PMID 32956536.



### 대부분은 여기서 끝납니다

특발성 야간 하지경련 대부분은 **설명과 스트레칭**에서 끝납니다. 간경변·투석·임신은 앞 장의 따로 보는 길을 따릅니다.

Tip · 약은 스트레칭과 유발요인 정리 다음 이야기입니다.

근거 · PMID 22341378 · 32956536

## 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

### **광고바른내과**

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

### **이 자료의 성격**

1차 진료 관점의 **의료진 학습자료**입니다. 인용은 각 슬라이드의 PubMed 링크를 따르며, 실제 처방·시술 결정은 최신 1차 자료와 임상 판단으로 최종 확인하십시오.

### **참고한 자료**

원문 임상 지침(근육 경련·야간 하지 경련) · 스트레칭 RCT · Cochrane 마그네슘 · Cochrane 퀴닌 · 간경변  
타우린 RCT



SCAN TO REVISIT

**휴대폰에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 같은 자료를  
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다